Клинические рекомендации

Краниальные мононейропатии у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B02.2** — Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G50.0** — Невралгия тройничного нерва **G50.1** — Атипичная лицевая боль **G50.8** — Другие поражения тройничного нерва **G50.9** — Поражение тройничного нерва неуточненное **G51.0** — Паралич Белла **G51.1** — Воспаление узла коленца **G51.2** — Синдром Россолимо-Мелькерссона **G51.3** — Клонический гемифациальный спазм **G51.4** — Лицевая миокимия **G51.8** — Другие поражения лицевого нерва **G51.9** — Поражение лицевого нерва неуточненное **G52.0** — Поражения обонятельного нерва **G52.1** — Поражения языкоглоточного нерва **G52.2** — Поражения блуждающего нерва **G52.3** — Поражения подъязычного нерва **G52.7** — Множественные поражения черепных нервов **G52.8** — Поражения других уточненных черепных нервов **G52.9** — Поражение черепного нерва неуточненное **G53.0** — Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2+) **G90.0** — Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Некоммерческая организация «Ассоциация интервенционного лечения боли»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/895_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **4**

2. Клиническая картина и классификация **4**

2.1 Тройничный нерв: определения 4

2.2 Лицевой нерв: определения 5

2.3 Причины 5
2.4 Классификация 7
2.5 Клиническая картина: тригеминальная невралгия 7
2.6 Клиническая картина: тригеминальные автономные цефалгии 8
2.7 Клиническая картина: нейропатия лицевого нерва 9
2.8 Клиническая картина: гемифациальный спазм и миокимия 10
2.9 Клиническая картина: другие черепные нервы 11
3. Диагностика 11
3.1 Критерии диагноза 11
3.2 Жалобы и анамнез 12
3.3 Неврологический осмотр 13
3.4 Анализы крови 15
3.5 МРТ головного мозга 15
3.6 КТ височной кости и другие лучевые исследования 16
3.7 Видеоларингоскопия 17
3.8 УЗИ 17
3.9 Электронейромиография 17
3.10 Консультация оториноларинголога 17
3.11 Другие консультации 18
3.12 Направление к хирургу при нейропатии лицевого нерва 18
4. Лечение 19
4.1 Тригеминальная невралгия: подходы 19
4.2 Тригеминальная невралгия: купирование приступа 20
4.3 Тригеминальная невралгия: хроническая боль 21
4.4 Тригеминальная невралгия: малоинвазивные вмешательства 21
4.5 Тригеминальная невралгия: операции 21
4.6 Атипичная лицевая боль: лекарства 22
4.7 Атипичная лицевая боль: психотерапия и вмешательства 22
4.8 Тригеминальная нейропатическая боль 23
4.9 Кластерная головная боль 24
4.10 Другие тригеминальные автономные цефалгии 24
4.11 Паралич Белла: лекарства 25
4.12 Нейропатия лицевого нерва: ботулинотерапия 25
4.13 Нейропатия лицевого нерва: операции 25
4.14 Гемифациальный спазм 27
4.15 Лицевая миокимия 27
4.16 Невралгия языкоглоточного нерва 27
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 28
5.1 Реабилитация при нейропатии лицевого нерва 28
5.2 Диспансерное наблюдение 29
5.3 Показания к госпитализации 29
5.4 Исход 30
6. Источник и актуальность 30

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 30

1. Основные положения

- Поражения тройничного нерва (невралгия, атипичная лицевая боль, нейропатическая боль, автономные цефалгии), лицевого нерва (нейропатия, гемифациальный спазм, миокимия) и других черепных нервов.
- Паралич Белла — диагноз исключения; развивается за 24–48 часов, максимум за 72 часа. Глюкокортикоиды — **как можно раньше, лучше в первые 72 часа**, при любой тяжести; при тяжёлой форме — вместе с противовирусными.
- Нейропатия лицевого нерва — всем оториноларинголог с отоскопией, по показаниям аудиометрия и тимпанометрия. Снижение слуха на стороне поражения нехарактерно — заподозрить объёмное образование.
- «Красные флаги» или симптомы **более 3 недель** — МРТ головного мозга с контрастом.
- Тяжёлая нейропатия (V–VI степень) — ЭНМГ **не ранее 8 суток**: М-ответ ниже на 90% и более — к хирургу. Электростимуляция и форсированные упражнения не рекомендуются.
- Тригеминальная невралгия: препараты первой линии — карбамазепин и окскарбазепин.
- Невралгия языкоглоточного нерва — приступы боли по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла челюсти, в ухе; обследование включает МРТ, УЗИ шеи и видеоларингоскопию.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Тройничный нерв: определения

Тригеминальная невралгия — односторонние повторяющиеся кратковременные приступы боли по типу удара током, внезапно начинающиеся и прекращающиеся, провоцируемые безболевыми раздражителями, в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва. Может сопровождаться постоянной фоновой болью умеренной интенсивности.

Атипичная лицевая боль и нейропатическая боль

Состояние	Определение
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	постоянная боль в лице, ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев**, без выраженных неврологических нарушений и предшествующей причины
Миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом	боль от внезапного непроизвольного обратимого тонического сокращения жевательной мышцы; возможно острое нарушение прикуса
Синдром пылающего рта	жжение или дизестезия в полости рта ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев** без признаков основного заболевания
Тригеминальная нейропатическая боль	боль в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва, вызванная другим заболеванием и указывающая на повреждение нерва

Тригеминальные автономные (вегетативные) цефалгии — первичные головные боли

1. **кластерная головная боль** — короткие односторонние атаки крайне сильной боли в области орбиты, подглазничной или височной области с вегетативными симптомами со стороны глаза и носа
2. **пароксизмальная гемикрания** — строго односторонняя боль в области орбиты, подглазничной или височной области по 2–30 минут, много раз в день, с вегетативными симптомами; купируется индометацином
3. **SUNCT** — короткие односторонние атаки боли в глазничной и окологлазничной области, всегда с инъекцией конъюнктивы и слезотечением
4. **SUNA** — то же, но инъекции конъюнктивы и слезотечения нет или есть только один из этих симптомов
5. **гемикрания континуа** — непрерывная односторонняя головная боль умеренной интенсивности с обострениями и вегетативными симптомами, абсолютный эффект индометацина

2.2 Лицевой нерв: определения

Нейропатия лицевого нерва — асимметрия лица из-за односторонней слабости мимических мышц (прозопарез — движения есть, прозоплегия — нет) с неполным закрытием глаза; симптомы по уровню поражения и поздние осложнения — ниже. Паралич Белла — идиопатическая форма.

Гемифациальный спазм — хронические пароксизмальные безболезненные непроизвольные односторонние тонические или клонические сокращения мышц лица, в том числе в покое и ночью.

Лицевая миокимия — спонтанные односторонние низкоамплитудные пульсирующие подёргивания одной мышцы лица (чаще нижней порции круговой мышцы глаза), от секунд до часов, реже до недель; заметнее пациенту, чем окружающим.

Краниальная невропатия — любое повреждение черепного нерва на любом уровне.

Уровни поражения лицевого нерва

1. мосто-мозжечковый угол;
2. внутренний слуховой проход;
3. костный канал до отхождения большого каменистого нерва;
4. костный канал до отхождения стремянного нерва;
5. выход через шилососцевидное отверстие;
6. околоушная железа;
7. отдельные ветви в мимических мышцах.

2.3 Причины

1. **Классическая тригеминальная невралгия** — нейроваскулярный конфликт — сдавление корешка сосудом, чаще верхней мозжечковой артерией
2. **Симптоматическая** — опухоль, артериовенозная мальформация, демиелинизация при рассеянном склерозе
3. **Идиопатическая** — причина неизвестна

Паралич Белла — диагноз исключения. Основные гипотезы — вирусная (реактивация HSV-1, HSV-2, VZV на фоне стресса, переохлаждения, другой инфекции) и аутоиммунная. Связан с осенью, перепадами температуры, сахарным диабетом.

1. **Синдром Рамсея Ханта** — герпетическое поражение коленчатого узла: прозопарез или прозоплегия на фоне боли и кожных высыпаний; у 50–85% тяжелее паралича Белла, склонен к рецидивам
2. **Синдром Россолимо — Мелькерссона** — генетическое заболевание: рецидивирующий прозопарез с отёком губ и складчатым языком
3. **Объёмные образования (8–12%)** — шванномы лицевого нерва, опухоли мосто-мозжечкового угла и околоушной железы
4. **Другие частые причины** — осложнения хирургических, косметологических и стоматологических вмешательств, черепно-мозговая травма, неврологические заболевания, инфекции, метаболические нарушения; реже — радиохирургия вестибулярной шванномы
5. **Боррелиоз** — изолированная нейропатия лицевого нерва у 34–56% — учитывать при дифференциальной диагностике

Гемифациальный спазм

1. **первичный** — сдавление корешка лицевого нерва сосудом, чаще передней нижней мозжечковой артерией
2. **вторичный** — опухоль мосто-мозжечкового угла или околоушной железы, сосудистые аномалии, аномалия Киари, инфекции сосцевидного отростка и уха (средний отит, холестеатома), травма, поражение ствола мозга, перенесённая нейропатия лицевого нерва (постпаралитический гемиспазм)
3. **провоцируют** — холод, яркий свет, стресс

Синкинезии — непроизвольное сокращение одной группы мышц (или работа железы) при произвольном сокращении другой. Чаще всего окуло-скуловая и окуло-оральная (более 90%), оро-окулярная (59%), «крокодиловы слёзы» — слезотечение при жевании. Несколько синкинезий вместе — постпаралитический гемиспазм.

Первичная миокимия — от физического или эмоционального перенапряжения, кофеина, проходит сама. Вторичная — побочный эффект препаратов (топирамат, габапентин), дебют рассеянного склероза, объёмного процесса ствола, вестибулярной шванномы, тиреотоксикоза.

Невралгия языкоглоточного нерва

1. **классическая** — нейроваскулярный конфликт
2. **вторичная** — травма шеи, рассеянный склероз, тонзиллярные или регионарные опухоли, опухоль мосто-мозжечкового угла, мальформация Арнольда — Киари
3. **идиопатическая** — причина не найдена

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп — проявления другого заболевания

1. нарушение мозгового кровообращения;
2. травма головы и шеи;
3. тромбоз венозных синусов;
4. воспалительные заболевания околоносовых пазух;
5. опухоли головы и шеи;
6. системные и метаболические заболевания;
7. миастения, боковой амиотрофический склероз;
8. сосудистые мальформации.

Тригеминальная нейропатическая боль — после травмы нерва, герпетической инфекции и других причин; постгерпетическая невралгия — реактивация Herpes zoster.

2.4 Классификация

Тригеминальная невралгия: классическая, идиопатическая, симптоматическая. По Burchiel: 1 тип — только типичные прострелы; 2 тип — ещё и постоянная фоновая боль.

Атипичная лицевая боль (ICOP)

1. синдром пылающего рта: без соматосенсорных изменений, с соматосенсорными изменениями, возможный;
2. персистирующая идиопатическая лицевая боль: без соматосенсорных изменений, с ними, возможная;
3. миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом.

«Возможный» — те же признаки, но **менее 3 месяцев**.

Тригеминальная нейропатическая боль (ICOP)

1. связанная с Herpes zoster;
2. постгерпетическая невралгия;
3. посттравматическая (и возможная посттравматическая);
4. связанная с другим нарушением (и возможная);
5. идиопатическая.

Тригеминальные автономные цефалгии

1. **эпизодическая кластерная головная боль** — не менее 2 периодов **более 7 дней** в году, ремиссия **более 3 месяцев** (около 80% пациентов)
2. **хроническая кластерная головная боль** — приступы **1 год** без ремиссий или с ремиссиями **менее 3 месяцев**
3. **пароксизмальная гемикрания** — эпизодическая — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **от 1 месяца**; хроническая — **более 1 года** без ремиссий или с ремиссией менее 1 месяца
4. **SUNCT и SUNA** — эпизодические — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **3 месяца и более**; хронические — более 1 года без ремиссии или с ремиссией менее 3 месяцев
5. **гемикрания континуа** — ремиттирующая (ремиссия не менее 1 дня без лечения) и неремиттирующая

Нейропатия лицевого нерва: идиопатическая (G51.0) и симптоматическая (G51.1, G51.2, G51.8, G51.9), поражение отдельных ветвей (G51.8). Гемифациальный спазм — первичный (G51.3) и вторичный. Лицевая миокимия — первичная (G51.4) и вторичная.

Языкоглоточный нерв (ICOP)

1. невралгия: классическая, идиопатическая, вторичная;
2. нейропатическая боль: с установленной причиной, идиопатическая.

2.5 Клиническая картина: тригеминальная невралгия

Диагноз — клинический, по характеру боли

1. приступ **от доли секунды до 2 минут**;
2. высокая интенсивность;
3. боль как электрический разряд, стреляющая, колющая, острая;
4. провокация безболевым воздействием на триггерные точки.

Провоцируют холодный воздух, чистка зубов, умывание, разговор, еда. Чувствительных нарушений нет — кроме симптоматической невралгии.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль

1. постоянная тупая ноющая боль, без атак и курковых зон;
2. не соответствует зонам иннервации ветвей тройничного нерва;
3. чаще в области верхней челюсти, распространяется на периорбитальную область, нос, щёку, висок; бывает в одном зубе (атипичная одонталгия);
4. ночью обычно стихает, но у 50–70% нарушен сон;
5. обостряется от холода, стресса, хирургических и стоматологических вмешательств.

Миофасциальная боль со спазмом жевательной мышцы: внезапная боль и ограничение движений челюсти.

Синдром пылающего рта: постоянная жгучая боль на неизменённой слизистой, чаще языка, обычно двусторонняя, к вечеру сильнее; изменение вкуса и сухость во рту при нормальном слюноотделении.

Нейропатическая боль: негативные симптомы (гипестезия, анестезия) и позитивные (гипералгезия, аллодиния, гиперпатия, спонтанная боль, парестезии); аллодиния бывает механическая, температурная, двигательная. Постгерпетическая невралгия — жгучая, колющая боль с парестезией, гипералгезией, зудом, потерей чувствительности и аллодинией.

Нейропатическая боль: симптомы и механизмы

Симптом	Механизм
длительная жгучая боль	нарушение центрального тормозного контроля, центральная сенситизация, эктопические разряды
стреляющая, пронзающая боль	эктопические разряды
парестезия, дизестезия	эктопические разряды, центральная сенситизация
гипералгезия	центральная сенситизация от усиления ноцицептивной афферентации
механическая аллодиния	нарушение центрального торможения, центральная сенситизация, сенситизация ноцицепторов
парадоксальные реакции на температуру	нарушение центрального тормозного контроля
онемение, утрата чувствительности	дегенерация сенсорных волокон, нарушение центрального тормозного контроля

2.6 Клиническая картина: тригеминальные автономные цефалгии

Кластерная головная боль: односторонняя очень сильная боль в области глазницы, подглазничной или височной области, **15–180 минут**, чаще ночью; пациент возбуждён, не находит себе места.

Вегетативные симптомы на стороне боли

1. слезотечение (91%);
2. инъекция конъюнктивы (77%);
3. заложенность носа (75%);
4. птоз, отёк век, миоз;
5. ринорея;
6. потливость и покраснение лица.

Триггеры: алкоголь, вазодилататоры, нарушение сна, перепады давления (авиаперелёт, дайвинг), смена погоды, запахи.

Пароксизмальная гемикрания: сильная боль в области орбиты с вегетативными симптомами по **2–30 минут**, приступы в течение всего дня.

SUNCT и SUNA: короткие (секунды — минуты) приступы боли в области орбиты, часто от прикосновения к коже; при SUNA — чаще в виске, со слезотечением, заложенностью носа, ринореей, без рефрактерного периода (в отличие от тригеминальной невралгии).

Гемикрания континуа: односторонняя боль средней интенсивности с обострениями — в височной, глазничной, лобной, ретроорбитальной или затылочной области.

2.7 Клиническая картина: нейропатия лицевого нерва

Уровень поражения лицевого нерва

Уровень поражения	Симптомы, кроме слабости мимических мышц
мосто-мозжечковый угол	нарушение функции тройничного, отводящего и преддверно-улиткового нервов
внутренний слуховой проход	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, снижение слуха на стороне поражения, головокружение
костный канал до отхождения большого каменистого нерва	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
до отхождения стремянного нерва	слезотечение, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
выход через шилососцевидное отверстие	только двигательные нарушения и слезотечение
околоушная железа	только двигательные нарушения
отдельные ветви	только двигательные нарушения в зоне иннервации

Диагноз — по осмотру, МРТ и ЭНМГ. Паралич Белла развивается за **24–48 часов**, **максимум за 72 часа**.

Признаки уровня и причины

1. слабость только нижней группы мимических мышц — центральное поражение или поражение отдельных ветвей;
2. гиперакузия, нарушение вкуса, сухость во рту — периферическое поражение выше отхождения стремянного нерва;
3. **снижение слуха на стороне поражения** нехарактерно — заподозрить объёмное образование;
4. боль в ухе или за ухом — симптом идиопатической нейропатии или отогенного процесса;
5. рецидив — у 6,5%; нейропатия в анамнезе ставит идиопатическую форму под сомнение.

«Красные флаги» — нужны дополнительные исследования и консультации

1. симптомы нарастают **более 72 часов**;
2. тяжесть пареза колеблется;
3. слабы только мышцы нижней половины лица;
4. эпизод слабости мышц лица в анамнезе;
5. поражены обе половины лица;
6. снижение слуха;
7. головокружение;
8. другие неврологические симптомы.

У **60–70%** функция восстанавливается полностью или частично **за 3–6 месяцев**, но из-за частых осложнений заболевание считают прогрессирующим и наблюдают. Гипертонус мышц здоровой стороны — **с 7-го дня** у 67%; синкинезии — **с 4 месяцев до года**. Лагофтальм — у 3/4 пациентов, ведёт к ксерозу роговицы, кератиту, язве.

Первичные двигательные нарушения

1. снижение силы и тонуса мышц поражённой стороны;
2. лагофтальм.

Вторичные

1. гипертонус или контрактуры мышц здоровой или поражённой стороны;
2. атрофия мышц поражённой стороны;
3. синкинезии до постпаралитического гемиспазма.

Факторы риска контрактур и синкинезий

1. тяжёлое поражение: прозоплегия, по ЭНМГ поражение нерва **более 90%**;
2. активная стимуляция мышц: ЛФК с максимальной амплитудой движений, электростимуляция.

Изолированное поражение краевой нижнечелюстной ветви (после стоматологических и косметологических вмешательств, операций на голове и шее, травм) — асимметрия улыбки, ошибочно принимаемая за центральное поражение; выявляется пробой «Ы-Ы».

2.8 Клиническая картина: гемифациальный спазм и миокимия

Гемифациальный спазм: спонтанный односторонний клонический и (или) тонический спазм мышц лица, в покое и во сне; бывают щелчки в ухе (сокращение стременной мышцы) и боль как при невралгии тройничного нерва. Обычно начинается с круговой мышцы глаза. Двусторонний — менее 5%.

«Красные флаги» при лицевой миокимии

1. подёргивания и в других мышцах лица или тела;
2. двусторонний процесс;
3. глаз открывается с трудом, опущение века;
4. покраснение или отёк века, боль;
5. не проходит за несколько недель;
6. другие неврологические симптомы.

Непроизвольные движения лица

Состояние	Отличительный признак
Лицевая миокимия	периодические низкоамплитудные сокращения 1–2 мышц, проходят сами, заметнее пациенту
Блефароспазм, лицевой параспазм	длительные прогрессирующие двусторонние скручивающие движения, вовлекаются соседние мышцы
Синкинезии	только при определённом движении: одна мышца провоцирует сокращение другой
Тики	дебют в 3–7 лет, прогрессируют только до подросткового возраста
Эпилепсия с миоклонией век (синдром Дживонса)	миоклония век с абсансами или без, дрожание век с двух сторон сразу после медленного закрытия

2.9 Клиническая картина: другие черепные нервы

1. **Обонятельный** — гипосмия, аносмия, гиперосмия
2. **Глазодвигательные** — птоз, косоглазие, диплопия, изменение ширины зрачка, нарушение конвергенции, аккомодации и сочетанных движений глаз
3. **Языкоглоточный** — невралгия — пароксизмальная боль по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла нижней челюсти и (или) в ухе; нейропатия — расстройство вкуса задней трети языка, снижение чувствительности верхней половины глотки; болевая нейропатия — постоянная боль в зоне нерва

1. **Блуждающий** — редко изолированно; парез мышц глотки и голосовых складок — дисфагия, дисфония, дизартрия; тахи- или брадикардия; при двустороннем поражении — нарушение ритма дыхания
2. **Добавочный** — голова отклонена в больную сторону, ограничен поворот в здоровую, затруднено поднимание плеч; позже атрофия грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц
3. **Подъязычный** — парез половины языка, язык отклоняется в сторону поражения; при ядерном поражении — атрофия и фибриллярные подёргивания; двустороннее — глоссоплегия, дизартрия или анартрия

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Тригеминальная невралгия — диагноз клинический. Нейроваскулярный конфликт на МРТ сам по себе не основание для диагноза классической невралгии. То же для невралгии языкоглоточного нерва.

Общепринятых критериев для поражений лицевого нерва нет: диагноз — по жалобам, анамнезу, осмотру и инструментальным данным. Цель — установить уровень поражения, причину, тяжесть и прогноз восстановления.

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп — по жалобам и неврологическому осмотру; нужно найти основное заболевание.

Критерии диагноза: атипичная лицевая боль

Форма	Критерии
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	ежедневно более 2 часов более 3 месяцев; плохо локализована, не соответствует зоне нерва; тупая, ноющая или тянущая; обследование патологии не выявляет
Миофасциальная боль со спазмом	спазм жевательной мышцы, боль связана со спазмом по времени и динамике; боль в челюсти, виске, ухе или перед ухом, вызывается пальпацией мышцы или открыванием рта
Синдром пылающего рта	ежедневно более 2 часов более 3 месяцев; жжение поверхностно в слизистой; слизистая не изменена, местные и системные причины исключены

Критерии диагноза: тригеминальная нейропатическая боль

Форма	Критерии
Связанная с Herpes zoster	односторонняя боль менее 3 месяцев; высыпания в зоне нерва или VZV в ликворе (ПЦР) или в материале из очагов; бывает без высыпаний (zoster sine herpete)
Постгерпетическая невралгия	боль более 3 месяцев в зоне ветвей, поражённых Herpes zoster, связана с ним по времени

Форма	Критерии
Посттравматическая	боль **более 3 месяцев**, повреждение нерва в анамнезе и по исследованиям, начало **не позднее 6 месяцев** после травмы, соматосенсорные симптомы в той же зоне; часто — после стоматологического лечения
Связанная с другим нарушением	боль 3 месяца и более, есть способное её вызвать расстройство, соматосенсорные симптомы в зоне боли
Идиопатическая	боль 3 месяца и более с соматосенсорными симптомами, поражение нерва есть, травмы и другой причины нет

Критерии диагноза: тригеминальные автономные цефалгии

Форма	Критерии
Кластерная головная боль	не менее 5 атак; сильная односторонняя боль в глазничной, подглазничной и (или) височной области **15–180 минут**; на стороне боли — инъекция конъюнктивы или слезотечение, заложенность носа или ринорея, отёк век, потливость лица, миоз или птоз, и (или) беспокойство; от 1 раза в 2 дня до 8 раз в день
Пароксизмальная гемикрания	не менее 20 атак по **2–30 минут**, более 5 в день, те же вегетативные симптомы, полностью проходит от индометацина
SUNCT	не менее 20 атак **1–600 секунд**, с вегетативными симптомами, не реже раза в день
SUNA	не более одного из симптомов: инъекция конъюнктивы, слезотечение
Гемикрания континуа	односторонняя боль **более 3 месяцев** с обострениями, вегетативные симптомы (в том числе ощущение распирания в ухе), абсолютный эффект индометацина

3.2 Жалобы и анамнез

Асимметрия лица от слабости мимических мышц — активный сбор жалоб и анамнеза, включая эпиданамнез: центральный или периферический уровень, причина.

Уточнить

1. длительность и скорость развития, порядок появления симптомов;
2. слабость верхней и нижней групп мимических мышц;
3. гиперакузию, нарушение вкуса, сухость во рту;
4. боль в ухе или за ухом накануне или в начале асимметрии;
5. травмы, операции, косметологические и стоматологические вмешательства;
6. гипертоническую болезнь, сахарный диабет, неврологические заболевания, беременность;
7. лихорадку, увеличение лимфатических узлов, покраснение или отёк тканей головы и шеи;
8. высыпания на лице, в околоушной области, в ушной раковине;
9. пребывание в регионах клещевого энцефалита **в течение месяца** до начала.

Есть «красные флаги» — расширенное клинико-лабораторно-инструментальное обследование.

«Красные флаги» при лицевой боли — признаки вторичной природы

1. внезапное начало;
2. лихорадка, сыпь, менингеальные симптомы;
3. боль усиливается при перемене положения, нагрузке, кашле, чихании;
4. нарастающая боль, резистентная к лечению;
5. боль впервые **после 50 лет**;
6. изменения неврологического статуса;
7. необъяснимая потеря веса, гипергидроз;
8. онкологическое заболевание, иммунодефицит, длительный приём глюкокортикоидов.

Атипичная лицевая боль — диагноз по критериям Международной классификации орофациальной боли.

Боль в зоне ветвей тройничного нерва — анамнез, жалобы, оценка боли и чувствительных нарушений в лице. Нейропатический характер подтверждают опросниками DN-4, painDETECT, LANSS.

3.3 Неврологический осмотр

Тригеминальная невралгия — осмотр невролога: чувствительность в зонах ветвей тройничного нерва, бимануальная пальпация жевательных мышц, провокация боли с триггерных точек. Цель — исключить симптоматическую невралгию, дисфункцию ВНЧС, миофасциальную боль.

Атипичная лицевая боль — неврологический, соматический и местный статус; при «красных флагах» — поиск причин вторичной боли.

Осмотр головы и шеи: повреждения и цвет кожи, отёк; пальпация лимфатических узлов и слюнных желёз. Пальпация мышц лица с усилием **1 кг**: **2 секунды** — местная боль, **5 секунд** — отражённая.

Подозрение на тригеминальную нейропатическую боль — чувствительность в зонах ветвей, корнеальный рефлекс, депигментация или пигментация кожи лица.

Сомнительный диагноз тригеминальной нейропатической боли — бимануальная пальпация жевательных и височных мышц: исключить дисфункцию ВНЧС.

Впервые возникшая боль в зоне глазничной ветви **после 50 лет** с эпизодами amaurosis fugax — пальпация поверхностной височной артерии: исключить гигантоклеточный артериит.

Тригеминальные автономные цефалгии — осмотр невролога: исключить вторичный характер.

Асимметрия лица — осмотр невролога с пальпацией околоушных слюнных желёз и лимфатических узлов.

Оценить силу каждой мимической мышцы, тонус на обеих сторонах, смещение средней линии лица, синкинезии — уровень и степень поражения.

Проверка мимических мышц

Мышца	Проба
лобное брюшко надчерепной мышцы	поднять брови
мышца, сморщивающая бровь	нахмуриться
круговая мышца глаза, вековая часть	спокойно закрыть глаза
круговая мышца глаза, орбитальная часть	зажмуриться

Мышца	Проба
мышцы, поднимающие верхнюю губу, крыло носа, угол рта	показать «оскал»
малая и большая скуловые	сомкнуть губы и улыбнуться
щёчная	надуть щёки
мышца смеха	широко улыбнуться с разомкнутыми губами
круговая мышца рта	вытянуть губы трубочкой
опускающая угол рта	грустная улыбка
опускающая нижнюю губу	опустить губу, сказать «Ы-Ы»
подбородочная	поднять нижнюю губу
подкожная мышца шеи	сказать «Ы-Ы» и напрячь шею

Патологические синкинезии

Синкинезия	Проявление
оро-окулярная	при вытягивании губ, надувании щёк, жевании сужается глазная щель
окуло-фронтальная	при моргании и зажмуривании морщится лоб
окуло-скуловая	при моргании и зажмуривании углубляется носогубная складка
окуло-назальная	при моргании и зажмуривании сокращается носовая мышца (может быть физиологической)
синкинезия Гюйе	при зажмуривании крыло носа поднимается вверх и кнаружи
окуло-оральная	при моргании и зажмуривании сокращаются носогубная складка, скуловые мышцы, верхняя губа
окуло-платизменная	зажмуривание напрягает подкожную мышцу шеи
окуло-аурикулярная	при зажмуривании поднимается ушная раковина
фронто-назальная	поднимание бровей сокращает носовую мышцу
фронто-оральная	при наморщивании лба сокращается угол рта
синкинезия Марина-Амата	открывание рта или боковые движения челюсти закрывают веки (редко)
«крокодиловы слёзы»	слезотечение на поражённой стороне при жевании
окуло-стапедиальная	при моргании и закрывании глаз — одностороннее снижение слуха или шум в ухе
звукоиндуцированная	звуки (клавиши, хлопки, труба) вызывают сокращение мимических мышц
ретроаурикулярная боль	хроническая боль за ухом во время менструации после паралича Белла

Тяжесть — по шкале House-Brackmann с записью в документацию; для наблюдения в динамике — шкала Sunnybrook (чувствительнее).

Оценить лагофтальм: смыкание век спокойно и с усилием, расстояние между веками в мм, положение век, инъекция конъюнктивы — для ранней профилактики осложнений и направления к офтальмологу.

Повторный осмотр невролога в течение нескольких месяцев после начала восстановления — профилактика и лечение осложнений, в том числе глазных.

Гемифациальный спазм — осмотр невролога с пальпацией околоушных желёз и лимфатических узлов, оценка всех мимических мышц и непроизвольных движений; возможны прозопарез и гипертонус.

Лицевая миокимия — тот же осмотр: выявить «красные флаги».

Подозрение на невралгию языкоглоточного нерва — неврологический осмотр с пальпацией: исключить вторичную причину.

3.4 Анализы крови

Нейропатия лицевого нерва — развёрнутый общий анализ крови: сдвиг формулы к нейтрофилам — неблагоприятный прогноз.

Биохимический анализ крови с глюкозой натощак — исключить метаболические причины.

Сахарный диабет — гликированный гемоглобин: понадобятся высокие дозы глюкокортикоидов.

Подозрение на инфекционную причину — в начале болезни антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, вирусу простого герпеса, VZV, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна — Барр, вирусу герпеса 6 типа.

Подозрение на клещевой энцефалит — антитела к вирусу клещевого энцефалита.

ТТГ — при гипотиреозе риск нейропатии лицевого нерва выше.

Гемифациальный спазм — общий и биохимический анализ крови с глюкозой: исключить вторичные формы.

Лицевая миокимия — анализы только при «красных флагах».

Синдром пылающего рта — анализы крови

1. общий и биохимический с глюкозой;
2. витамин B12, фолиевая кислота;
3. гемоглобин, железо, ферритин, трансферрин;
4. эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон.

Дефицит питания, диабет, климактерические нарушения указывают на вторичный синдром.

Не рекомендуется определять антитела к VZV для подтверждения постгерпетической невралгии: они слишком распространены в популяции.

Боль в зоне глазничной ветви **после 50 лет** с amaurosis fugax — СРБ и СОЭ; значимы СОЭ **≥ 50 мм/ч** или СРБ **≥ 10 мг/л**.

3.5 МРТ головного мозга

Тригеминальная невралгия — всем обзорная МРТ с 3D SPGR: исключить опухоль и демиелинизацию; при подозрении на них — с контрастом.

Фармакорезистентность, непереносимость или низкая приверженность лечению — МРТ в режимах FIESTA и 3D TOF: подтвердить или исключить нейроваскулярный конфликт.

Конфликт диагностируют при структурных изменениях корешка (дистопия, атрофия). Толщина среза **0,4–0,6 мм**, аппарат лучше 3 Тл, не менее 1,5 Тл.

Впервые выявленная атипичная лицевая боль с «красными флагами» — МРТ головного мозга.

Атипичная картина, «красные флаги», изменения неврологического статуса — МРТ головного мозга, мягких тканей головы, шейного отдела позвоночника и шеи.

Дифференциальный диагноз: патология костей черепа, болезни уха, синусит, патология челюстей, зубов, ВНЧС, краниальных нервов, тригеминальная и языкоглоточная невралгия, невралгия промежуточного нерва, внутричерепные опухоли и опухоли полости рта и др.

Возможная посттравматическая, возможная связанная с другим нарушением и идиопатическая тригеминальная нейропатическая боль — обзорная МРТ.

Впервые возникшие приступы SUNCT или SUNA — МРТ: исключить очаговое поражение мозга.

Впервые выявленные кластерная головная боль или пароксизмальная гемикрания — МРТ с контрастом: исключить опухоль, мальформацию, воспаление; гемикрания континуа — МРТ.

Кластерную головную боль отличают от других цефалгий, мигрени, височного артериита, тригеминальной невралгии, синусита, глаукомы, опухоли, мальформации, инсульта, диссекции артерий.

Нейропатия лицевого нерва с другими неврологическими симптомами — экстренно КТ или МРТ: исключить инсульт. При типичной картине экстренная МРТ не нужна.

Симптомы **более 3 недель** или «красные флаги» — МРТ головного мозга с контрастом по расширенному протоколу, по возможности с околоушной железой. Нельзя МРТ — КТ с контрастом.

Цель — исключить

1. объёмное образование;
2. воспаление, демиелинизацию;
3. инсульт;
4. нейроваскулярный конфликт.

При типичной картине объёмное образование находят в **8–12%**, из них 30% злокачественные. У 80% выздоравливающих восстановление начинается **в первые 2–3 недели**.

Гемифациальный спазм — всем МРТ по расширенному протоколу (3D-T2, 3D-TOF, FIESTA и др.): нейроваскулярный конфликт.

Нет конфликта на бесконтрастных сериях — МРТ с контрастом: опухоль и другие причины.

Лицевая миокимия: «красные флаги» — МРТ с контрастом; без них МРТ **не рекомендуется**.

Невралгия языкоглоточного нерва — всем МРТ с захватом краниовертебрального перехода и 3D SPGR; после исключения вторичных причин — FIESTA и 3D TOF (классическая невралгия).

3.6 КТ височной кости и другие лучевые исследования

Нейропатия лицевого нерва при подозрении на ЛОР-патологию или травму височной кости — КТ височной кости; нельзя — рентгенография височной кости.

Возможная связанная с другим нарушением и идиопатическая тригеминальная нейропатическая боль — ОПТГ, КЛКТ и (или) КТ или рентгенография околоносовых пазух: исключить одонтогенные причины и синусит.

Лицевая боль, не отвечающая критериям тригеминальной невралгии, — по клинической картине ОПТГ, КЛКТ, МРТ ВНЧС, УЗИ слюнных желёз, осмотр и пальпация мышц.

Невралгия языкоглоточного нерва без причины на МРТ — КТ краниовертебрального перехода: удлинённый шиловидный отросток, кальцинированная шилоподъязычная связка.

Подозрение на вторичную невралгию или нейропатическую боль языкоглоточного нерва без причины на МРТ головы — МРТ мягких тканей шеи с контрастом и жироподавлением.

3.7 Видеоларингоскопия

Невралгия языкоглоточного нерва — всем видеоларингоскопия: уточнить причину.

3.8 УЗИ

Нейропатия лицевого нерва неясной причины **более 3 недель**, если МРТ затруднена, — УЗИ околоушной слюнной железы.

Тяжёлое поражение по ЭНМГ **более 3 месяцев** — УЗИ мягких тканей лица: атрофия мышц, своевременное направление к хирургу.

Тяжёлое поражение **более 3 месяцев** и подозрение на атрофию — МРТ мягких тканей лица, прежде всего скуловых мышц: при тотальном поражении атрофия наступает быстро, позднее хирургическое лечение может быть нецелесообразно.

Гемифациальный спазм неясной причины — УЗИ околоушной слюнной железы (или МРТ).

Невралгия языкоглоточного нерва — всем УЗИ слюнных желёз и мягких тканей шеи.

3.9 Электронейромиография

Тяжёлая нейропатия лицевого нерва (V–VI степень по House-Brackmann) — стимуляционная ЭНМГ **не ранее 8 суток**, лучше **на 9–20 день**, с обеих сторон (круговые мышцы глаза и рта). Амплитуда М-ответа на поражённой стороне ниже **на 90% и более** — неблагоприятный прогноз, нужна игольчатая ЭМГ.

Асимметрия М-ответа более 90% — игольчатая ЭМГ не менее двух мышц верхней и нижней порций: нет потенциалов двигательных единиц при произвольном сокращении — тотальное поражение, неблагоприятный прогноз, показание к операции.

Отсутствие потенциалов двигательных единиц может не иметь прогностического значения **до 15 дня** — исследование повторяют.

Изолированное поражение ветви — игольчатая ЭМГ плегированной мышцы (например, опускающей нижнюю губу). При травме потенциалы могут появиться только на 4-м месяце.

Сохраняется тяжёлая нейропатия — игольчатая ЭМГ **через 6 месяцев** (можно **через 3 месяца** без восстановления и без травмы): нужна ли операция.

Неполное поражение (**менее IV степени**), движения есть во всех ветвях — ЭНМГ и ЭМГ **не рекомендуются**: прогноз благоприятный.

Миофасциальная боль со спазмом при недостатке данных — накожная ЭМГ: потенциалы двигательных единиц в покое.

Возможная и идиопатическая тригеминальная нейропатическая боль — коротколатентные вызванные потенциалы тройничного нерва (если повреждение не подтверждено иначе).

Персистирующая идиопатическая лицевая боль с подозрением на сенсорные нарушения — количественное сенсорное тестирование.

Тригеминальная нейропатическая боль — количественное сенсорное тестирование для объективизации нарушений.

3.10 Консультация оториноларинголога

Нейропатия лицевого нерва — всем оториноларинголог с отоскопией: исключить отогенную причину; по показаниям — аудиометрия и тимпанометрия.

Кондуктивная тугоухость — заподозрить опухоль лицевого нерва в пирамиде височной кости; **нейросенсорная** — сдавление нерва образованием в мосто-мозжечковом углу. Тимпанометрия оценивает акустический рефлекс стременной мышцы.

Подозрение на лицевую боль от заболевания околоносовых пазух (при тригеминальной невралгии и поражениях других черепных нервов) — оториноларинголог.

3.11 Другие консультации

Стоматолог — при сомнительном диагнозе тригеминальной невралгии или невралгии языкоглоточного нерва, всем с синдромом пылающего рта и персистирующей идиопатической лицевой болью, при подозрении на одонтогенную нейропатическую боль.

Синдром пылающего рта: слизистая должна быть без изменений; эрозии и язвы, не заживающие **2 недели**, — биопсия.

Челюстно-лицевой хирург — подозрение на боль от травм и других заболеваний челюстно-лицевой области.

Психиатр — тревога, депрессия, все случаи сомнительной тригеминальной невралгии после исключения орофациальной боли.

Синдром пылающего рта с тревогой, депрессией или болью **более 3 месяцев** — психиатр.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль с тревогой, депрессией или хронической болью — психиатр.

Миофасциальная боль со спазмом с тревогой, депрессией или хронической болью — психиатр.

Тригеминальная нейропатическая боль с тревогой и депрессией — психиатр.

Хроническая тригеминальная нейропатическая боль — медицинский психолог: факторы хронизации.

Тригеминальная невралгия с фармакорезистентностью, непереносимостью или низкой приверженностью лечению — нейрохирург.

Тригеминальная нейропатическая боль с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения — нейрохирург: пункционные и хирургические методы.

Невралгия языкоглоточного нерва с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения — нейрохирург.

Подозрение на демиелинизирующее заболевание по МРТ — невролог кабинета рассеянного склероза.

Нейропатическая боль, связанная с Herpes zoster, — дерматовенеролог и (или) инфекционист; при глазничной локализации — офтальмолог.

Боль в зоне глазничной ветви **после 50 лет** с amaurosis fugax — ревматолог: гигантоклеточный артериит.

Лагофтальм без осложнений — офтальмолог планово; **осложнённый** (покраснение, жжение, боль, светобоязнь, дефекты роговицы) — **экстренно**.

Подозрение на инфекционную нейропатию лицевого нерва — инфекционист.

Нейропатия лицевого нерва — психолог: социальная дезадаптация, неприятие внешности, тревога, апатия, нарушения сна; при суицидальных мыслях — психиатр.

Тяжёлая нейропатия (V–VI степень) или осложнения (гипертонус, синкинезии) — обязательно врач ЛФК; остальным — домашняя самореабилитация.

3.12 Направление к хирургу при нейропатии лицевого нерва

Операция — при неблагоприятных клинических и миографических признаках

1. **до 3 месяцев, идиопатическая форма** — декомпрессия лабиринтного сегмента нерва
2. **до 18 месяцев** — реиннервирующая операция
3. **позже** — реконструктивно-пластическая операция

Идиопатическая нейропатия тяжёлой степени — нейрохирург как можно раньше, но после ЭНМГ и ЭМГ (**не ранее 8 суток**): показания к декомпрессии.

Отбор: V–VI степень, разница М-ответа **более 90%**, рецидивы и другие причины исключены. Декомпрессию предпочтительно делают **в течение 14 дней**, через среднюю черепную ямку; возможна **до 3 месяцев**. Есть положительная динамика — не оперируют.

Тяжёлая нейропатия **после 3 месяцев** (идиопатическая или симптоматическая) — челюстно-лицевой хирург: реиннервирующая (до 18 месяцев) или реконструктивно-пластическая операция; учитывают атрофию по УЗИ или МРТ.

Постпаралитический гемиспазм с выраженными синкинезиями — челюстно-лицевой хирург: селективная нейрэктомия. Лёгкий и умеренный — ботулинический токсин и реабилитация.

Первичный гемифациальный спазм с нейроваскулярным конфликтом на МРТ — нейрохирург: васкулярная декомпрессия.

Вторичный гемифациальный спазм с объёмным образованием на МРТ — нейрохирург: показания к операции.

---

4. Лечение

4.1 Тригеминальная невралгия: подходы

Три подхода: консервативная терапия (профилактическое лечение и купирование приступов), малоинвазивные вмешательства, операции.

Всем с установленным диагнозом — профилактическая терапия, чтобы приступы стали реже. Препараты первой линии — карбамазепин и окскарбазепин, остальные — вторая линия (отдельно или вместе с первой).

Правила

1. начинать с монотерапии, препараты добавлять поочерёдно;
2. заменять препарат постепенно, по инструкции;
3. ремиссия — нет боли **не менее 4 недель**: медленно снижать дозу, можно отменить;
4. рецидив — постепенно вернуться к минимальной эффективной дозе;
5. на противоэпилептических препаратах — анализы крови **каждые 3–6 месяцев**: общий, биохимия (глюкоза, ЩФ, АЛТ, АСТ, билирубин), натрий, калий; по показаниям ЭКГ и концентрация препарата;
6. нет эффекта при хорошей переносимости — психиатр;
7. для направления к нейрохирургу не нужно перепробовать все препараты.

Профилактическое лечение тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
карбамазепин	100 мг 2 раза в день, повышать на 100–200 мг каждые 3 дня до 200 мг 4 раза в день	800–1200 мг	седация, головокружение, нечёткость зрения, тошнота, неустойчивость, вялость, диплопия, головная боль; гипонатриемия, кожная сыпь, панцитопения; остеопороз при длительном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
#окскарбазепин	150 мг 2 раза в день, повышать на 150–300 мг каждые 3 дня до 300 мг 4 раза в день	1200–1800 мг	сонливость, головокружение, диплопия, спутанность сознания, тошнота, боль в животе, головная боль, депрессия, диарея; высокий риск гипонатриемии; остеопороз при регулярном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов
#ламотриджин	25 мг 1 раз в день, повышать на 25 мг каждые 2 недели, после 100 мг — каждую неделю; свыше 100 мг — в 2 приёма	200 мг	нечёткость зрения, возбуждение, агрессия, неустойчивость, головокружение, тошнота, сухость во рту, бессонница, боль в суставах; сыпь и синдром Стивенса — Джонсона при быстром повышении дозы; можно отменять без титрации
#баклофен	5 мг 3 раза в день, повышать на 5 мг каждые 3 дня	40–80 мг	тревога, депрессия, возбуждение, неустойчивость, головная боль, седация, тремор, кожная сыпь, нечёткость зрения, сухость во рту, боль в животе; синдром отмены при слишком быстром прекращении
#габапентин	300 мг 1 раз в день, повышать на 300 мг ежедневно до 900 мг, затем на 300 мг каждые 3–5 дней	900–3600 мг	амнезия, спутанность сознания, головокружение, сонливость, депрессия, тошнота, нечёткость зрения, периферические отёки и отёки лица, запор, вздутие живота, прибавка веса
#прегабалин	75 мг 2 раза в день	600 мг	спутанность сознания, сонливость, запор, нечёткость зрения, головокружение, тошнота, периферические отёки и отёки лица, повышение аппетита, прибавка веса

Каждый из препаратов таблицы рекомендован отдельно; при непереносимости баклофена — можно #клоназепам. Знак # — применение вне инструкции.

Опиоиды для профилактического лечения **не рекомендуются**.

Дополнительно — ботулинический токсин типа А: 1,25–5 ЕД внутрикожно в триггерные точки через 15–20 мм, всего 25–100 ЕД.

Дополнительно — высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция.

4.2 Тригеминальная невралгия: купирование приступа

Острая боль — местные анестетики. Перед блокадой ветви — кожная проба.

Купирование приступа

Препарат	Применение
#лидокаин	10% спрей — 2 впрыскивания в носовой ход на стороне боли (частое применение повреждает слизистую из-за спирта); 5% гель на триггерную зону; 2% раствор с #эпинефрином 1:80 000 — блокада ветви; внутривенно 1,5–5 мг/кг дольше 1 часа
#ботулинический токсин типа А	50 ЕД в 1,0 мл 0,9% раствора натрия хлорида подкожно в триггерные точки

НПВП при тригеминальной невралгии **не рекомендуются**: при невропатической боли неэффективны. Если НПВП помогают — искать местное воспаление.

4.3 Тригеминальная невралгия: хроническая боль

Хроническая боль — #амитриптилин.

Хроническая боль — #дулоксетин.

Хроническая боль — #венлафаксин.

Хроническая боль при тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	12,5–75 мг	седация, сухость во рту, затруднение мочеиспускания, запор, нечёткость зрения, диплопия, повышение внутриглазного давления, нарушение памяти, тремор, аритмия
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг	головокружение, сонливость или бессонница, сухость во рту, тошнота, запор, потливость, снижение массы тела
#венлафаксин	с 18,75 мг 2 раза в день во время еды, повышать на 18,75 мг каждые несколько дней; после 75 мг — на 37,5 мг	75–225 мг	тошнота, снижение аппетита, запор, снижение массы тела, артериальная гипертензия, головокружение, бессонница, парестезии, тремор, нечёткость зрения, сексуальная дисфункция, потливость, высокая вероятность синдрома отмены

Психотерапия — когнитивно-поведенческая терапия, биологическая обратная связь, релаксация, майндфулнесс: меньше тревоги, депрессии, катастрофизации боли.

4.4 Тригеминальная невралгия: малоинвазивные вмешательства

Классическая невралгия в зоне надглазничного нерва при недостаточном эффекте лечения — термическая радиочастотная абляция надглазничного нерва под КТ или УЗИ; сначала диагностическая блокада.

В зоне подглазничного нерва — импульсная и (или) термическая радиочастотная абляция подглазничного нерва под КТ после диагностической блокады.

Идиопатическая или симптоматическая невралгия, если лечение основного заболевания не помогло или невозможно, — микробаллонная компрессия гассерова узла.

Там же — термическая радиочастотная абляция тройничного нерва.

Там же — глицериновая ризотомия.

4.5 Тригеминальная невралгия: операции

Фармакорезистентность или непереносимость лечения — нейрохирургическое лечение в специализированном отделении. 25–40% пациентов выбирают операцию в первые 2 года.

Классическая невралгия — микроваскулярная декомпрессия корешка (ретросигмоидный доступ), если на МРТ конфликт со структурными изменениями корешка; **старше 75 лет** — индивидуально.

Классическая невралгия, если декомпрессия невозможна или пациент отказался, — стереотаксическая радиохирургия корешка (до **90 Гр**, предпочтительно «Гамма-нож»); повторно — **не ранее 1 года**.

Классическая невралгия без эффекта лечения — имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Идиопатическая невралгия — стереотаксическая радиохирургия.

Идиопатическая невралгия при неэффективности других методов — частичная сенсорная ризотомия.

Идиопатическая невралгия при неэффективности других методов — имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Невралгия при рассеянном склерозе — стереотаксическая радиохирургия; при неэффективности — медиальная таламотомия.

При рассеянном склерозе и неэффективности других методов — частичная сенсорная ризотомия.

При рассеянном склерозе с нейроваскулярным конфликтом и изменениями корешка — микроваскулярная декомпрессия. Методы равноценны; безопаснее радиохирургия и пункционные вмешательства.

При рассеянном склерозе и неэффективности других методов — имплантация нейростимулятора.

Симптоматическая невралгия — операция по поводу причины (например, удаление опухоли) с декомпрессией корешка.

Симптоматическая невралгия без регресса боли после лечения причины — стереотаксическая радиохирургия.

Там же, при неэффективности других методов — частичная сенсорная ризотомия.

Симптоматическая невралгия при неэффективности других методов — имплантация нейростимулятора.

4.6 Атипичная лицевая боль: лекарства

Персистирующая идиопатическая лицевая боль — #амитриптилин: 6,25–12,5 мг вечером, повышать на 6,25–12,5 мг каждые 3–14 дней до 10–75 мг.

Противопоказания, плохая переносимость или неэффективность трициклических антидепрессантов — #венлафаксин: 18,75 мг 2 раза в день во время еды, повышать на 18,75 мг каждые несколько дней до 75 мг.

Не подошёл и венлафаксин — #флуоксетин 20 мг 1 раз в день.

Неэффективны или непереносимы антидепрессанты — габапентин (300 мг 1 раз в день с повышением до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг).

Недостаточен эффект лекарств — ботулинический токсин типа А в область боли.

Синдром пылающего рта — #амитриптилин с минимальной дозы на ночь, в среднем 10–50 мг в сутки.

Синдром пылающего рта — габапентин.

Синдром пылающего рта — #альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 600 мг в сутки; вместе с габапентином эффективнее.

Миофасциальная боль со спазмом — НПВП, лучше внутрь, не комбинировать, **10–14 дней**; учитывать риски со стороны ЖКТ и сердца.

Хроническая миофасциальная боль — #амитриптилин с 10 мг на ночь, до 150 мг в сутки.

Неэффективны антидепрессанты — #габапентин с 300 мг, повышать на 300 мг каждые 3 дня до 4200 мг.

Ботулинический токсин типа А в поражённые мышцы.

4.7 Атипичная лицевая боль: психотерапия и вмешательства

Персистирующая идиопатическая лицевая боль — когнитивно-поведенческая терапия.

Синдром пылающего рта — когнитивно-поведенческая терапия и психотерапия.

Миофасциальная боль — биологическая обратная связь для мышечного и психологического расслабления.

Миофасциальная боль — когнитивно-поведенческая терапия.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль без эффекта лекарств — импульсная радиочастотная абляция крылонёбного узла после положительной блокады (подскуловой доступ).

4.8 Тригеминальная нейропатическая боль

Габапентин (300 мг 1 раз в день, повышать до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг) — отдельно или в комбинации.

#Окскарбазепин — с 300 мг, повышать на 300 мг каждые 3 дня до 1800 мг в 2 приёма.

Антидепрессанты — отдельно или в комбинации с препаратами других групп; каждый из трёх препаратов таблицы рекомендован и отдельно (A, 1).

Антидепрессанты при нейропатической боли

Препарат	Схема	Доза в сутки
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	75 мг
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг
#венлафаксин	9,375–18,75 мг 2 раза в день, повышать на 9,375–18,75 мг каждые 3–7 дней	75–225 мг

Дополнительно — пластырь с 5% #лидокаином или гель с #лидокаином на область боли.

Опиоиды — третья линия из-за зависимости: тапентадол (B, 2), налоксон + оксикодон, трамадол, морфин (A, 1); доза индивидуально.

Дополнительно — #альфа-липоевая (тиоктовая) кислота 600 мг в сутки.

Психотерапия: когнитивно-поведенческая, биологическая обратная связь, релаксация, майндфулнесс.

Дополнительно — ботулинический токсин типа A в зоне боли.

Дополнительно — ритмическая ТМС 5–20 Гц, 5–10 сеансов, на моторную или дорсолатеральную префронтальную кору.

Постгерпетическая невралгия и посттравматическая боль — гипербарическая оксигенация, не менее 10 сеансов: меньше аллодинии и зуда.

Посттравматическая боль после облучения

1. **#альфа-токоферола ацетат** — выше 400 мг в сутки — вместе с ретинолом
2. **#пентоксифиллин** — 400 мг 2 раза в день 4–6 недель

Там же

1. **гипербарическая оксигенация** — не менее 10 сеансов
2. **глюкокортикоиды** — #дексаметазон 8–20 мг в сутки 3–5 дней с постепенной отменой или #преднизолон в эквивалентной дозе

Неэффективны другие методы — имплантация нейростимулятора прецентральной коры.

Постгерпетическая невралгия в зоне надглазничного нерва — импульсная или термическая радиочастотная абляция надглазничного нерва под КТ после диагностической блокады.

Постгерпетическая невралгия — имплантация системы периферической стимуляции ветвей после тестовой стимуляции.

Посттравматическая боль — имплантация нейростимулятора ветвей тройничного нерва после тестовой стимуляции.

Посттравматическая боль при неэффективности других методов — тригеминальная нуклеотрактотомия; риск неврологических осложнений.

4.9 Кластерная головная боль

Приступ — 100% кислород через маску (лучше с клапаном) **12 л/мин**, иногда 15 л/мин, **20 минут**.

Приступ — триптаны; предпочтительно золмитриптан 5–10 мг интраназально в противоположную ноздрю.

Приступ — спрей #лидокаина 4 дозы в ноздрю на стороне боли, полулёжа под 45°, голова повёрнута **на 30–40°** в сторону боли; действует около 2 часов.

Профилактика — #верапамил с **240 мг** в сутки, повышать на 80 мг каждые 3–4 дня, ЭКГ до начала и после 480 мг на каждые 160 мг; до 960 мг под наблюдением кардиолога.

На время подбора верапамила или при эпизодической форме **до 8 недель** — #преднизолон 100 мг утром 5 дней, затем снижать на 20 мг каждые 3 дня.

#Лития карбонат 353–900 мг; уровень лития 0,6–0,8 ммоль/л (не выше 1,2), контроль электролитов, почек, ТТГ, крови, ЭКГ.

#Мелатонин 10 мг.

#Топирамат с титрацией до 50–100 мг.

Тяжёлое течение до подбора лечения — блокады большого затылочного нерва анестетиком с глюкокортикоидом или без; эффект 2–4 недели.

Приступ — трансназальная блокада крылонёбного ганглия: тампон с 10% #лидокаином в носовой ход; эффект **через 30–40 минут**, **не менее 5 часов**.

Фармакорезистентная эпизодическая форма — радиочастотная абляция крылонёбного ганглия.

Фармакорезистентная хроническая форма после положительной блокады — радиочастотная абляция крылонёбного ганглия.

Фармакорезистентная хроническая форма — стимуляция затылочных нервов.

Фармакорезистентная хроническая форма — стимуляция крылонёбного ганглия.

4.10 Другие тригеминальные автономные цефалгии

Пароксизмальная гемикрания — #индометацин, до 250 мг в сутки.

SUNCT — #ламотриджин с 50 мг в сутки (при SUNA менее эффективен).

SUNCT — #габапентин с 300 мг, повышать на 300 мг каждые 3 дня, до 4200 мг.

SUNA — другие противоэпилептические средства.

Обострение SUNCT на время подбора лечения — #лидокаин внутривенно.

Гемикрания континуа — #индометацин 25 мг 3 раза в день 5–7 дней; нет эффекта — 50 мг, затем 75 мг 3 раза в день 2 недели.

4.11 Паралич Белла: лекарства

Как можно раньше, лучше в первые 72 часа, при любой тяжести — глюкокортикоиды: частота полного восстановления выше на 17%.

Дозы

1. #преднизолон внутрь **60 мг** 5 дней, затем снижать на 10 мг в сутки 5 дней;
2. или **1 мг/кг** 7–10 дней; при V–VI степени без противопоказаний — до **2 мг/кг** в сутки 10 дней;
3. всю дозу утром в 6:00–8:00 после еды или в 2 приёма в первой половине дня;
4. начало лечения **до 3 дней** и тяжесть выше IV степени — лучше однократно #метилпреднизолон **500 мг** внутривенно.

Интратимпанальное введение глюкокортикоидов **до 10 дней** вместе с системной терапией может улучшить исход, но данных пока недостаточно.

Противовирусные средства — вместе с глюкокортикоидами (в монотерапии неэффективны), на ранней стадии при тяжёлой нейропатии и (или) подтверждённой вирусной инфекции: ацикловир 800 мг 5 раз в сутки или валацикловир 1000 мг 3 раза в сутки.

Синдром Рамсея Ханта — рано глюкокортикоиды (#преднизолон или #метилпреднизолон) вместе с противовирусными, **курс 7 дней**.

Подозрение на болезнь Лайма — рано антибиотики: доксициклин, амоксициллин или цефуроксим по инструкции.

Боль в мышцах — НПВП, предпочтительно ибупрофен.

Комплекс витаминов группы В.

Неосложнённый лагофтальм — невролог сразу назначает увлажнение: днём искусственная слеза, на ночь декспантенол (гель); до нескольких раз в день и ночью.

4.12 Нейропатия лицевого нерва: ботулинотерапия

В остром периоде — в мышцы здоровой стороны при гипертонусе или высоком риске его (смещение средней линии ухудшает восстановление); в хроническом — в поражённую сторону при синкинезиях и в здоровую для симметрии. Интервал в среднем 5 месяцев; эффективнее вместе с реабилитацией. Побочно: гематома, избыточная слабость мышцы или соседних мышц (диплопия, нарушение речи).

Гипертонус мышц здоровой стороны умеренной и выраженной степени — ботулинический токсин типа А в мышцы здоровой стороны, всего **до 50 ЕД**, вместе с ЛФК.

Гипертонус поражённой стороны — инъекции с двух сторон, всего **до 100 ЕД**, вместе с ЛФК.

Постпаралитический гемиспазм умеренной и выраженной степени — инъекции с двух сторон, **до 100 ЕД**, вместе с ЛФК.

Поражение краевой нижнечелюстной ветви — в мышцу, опускающую нижнюю губу, на здоровой стороне: 5 ЕД в одну точку или по 2 ЕД в 2 точки.

4.13 Нейропатия лицевого нерва: операции

Метод выбирают по сроку, уровню, причине и тяжести поражения.

1. **патогенетическое лечение идиопатической формы** — декомпрессия нерва в канале височной кости — только при V–VI степени и разнице М-ответа более 90% с отсутствием потенциалов двигательных единиц
2. **симптоматическое лечение при любой форме** — реиннервирующая операция (**до 2 лет**, оптимально **до 18 месяцев**) или реконструктивно-пластическая; реиннервация — если нет динамики **6 месяцев**

Симптоматическое хирургическое лечение

Пациенты	Операция	Цель
тяжёлая нейропатия до 18 месяцев	реиннервирующие операции	восстановить функцию собственных мимических мышц
тяжёлая нейропатия более 18 месяцев	реконструктивно-пластические (аутотрансплантация мышцы)	заместить атрофированные мышцы
постпаралитический гемиспазм	селективная невротомия, нейрорафия, невролиз	естественная улыбка за счёт разобщения движений
лагофтальм	нейропластические, динамические и статические методы	восстановить или имитировать функцию круговой мышцы глаза

Паралич Белла тяжёлой степени — невролиз и декомпрессия лабиринтного сегмента лицевого нерва.

Сроки

1. лучше **в первые 14 дней**, через среднюю черепную ямку;
2. возможно **до 3 месяцев**;
3. при положительной динамике не оперируют.

Перед декомпрессией — КТ височной кости: ориентиры пирамиды, планирование доступа.

Перед декомпрессией — тональная аудиометрия: риск потери слуха на стороне операции **2–5%**.

Тяжёлая нейропатия **после 3 месяцев и до 2 лет** (лучше до 18 месяцев) — реиннервирующая операция (нейрорафия).

Тяжёлая нейропатия **более 2 лет** — реконструктивно-пластическая операция: свободная пересадка или перемещение мышц.

Выраженный постпаралитический гемиспазм — невролиз, нейрорафия, невротомия или миотомия; тщательный отбор из-за риска слабости мышц.

1. **интракраниальное повреждение до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» со вставкой из большого ушного нерва или «конец в конец» с челюстно-подъязычной или жевательной ветвью (С, 4)
2. **нет симметричных синхронных движений** — нейрорафия XII–VII «конец в конец» с икроножным нервом, в том числе по типу мионевротизации (С, 4)
3. **экстракраниальное повреждение с сохранением ствола и ветвей до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» с большим ушным нервом, «конец в конец» с жевательной ветвью или анастомоз V–VII с челюстно-подъязычной ветвью (в КР — «СВ», 4)

1. **экстракраниальное без сохранения ствола и ветвей до 2 лет** — ревизия со вставками из большого ушного и (или) икроножного нерва или нейрорафия XII–VII, V–VII со вставками (С, 4)
2. **интракраниальное более 2 лет с атрофией** — пересадка или перемещение мышц с реиннервацией жевательной ветвью и кросс-пластикой (С, 4); если невозможно — статическая коррекция фасцией (С, 4) или нитями

1. **интракраниальное повреждение** — нейрорафии XII–VII «бок в бок», V–VII «конец в бок», VII–VII «конец в бок» с икроножным нервом или с мионевротизацией (С, 4)
2. **экстракраниальное повреждение** — ревизия ствола и ветвей, нейрорафии, вставки, кросс-пластика (С, 4)

1. **контрактуры здоровой стороны** — селективная миотомия или нейротомия на здоровой стороне с мониторингом нерва, нейрорафия VII–VII (C, 4)
2. **контрактуры и синкинезии поражённой стороны** — нейрорафия VII–VII, селективная нейротомия, миотомия (C, 4)
3. **птоз тканей** — статическая коррекция фасцией или круговая подтяжка лица (C, 4)

Паралитический лагофтальм **более 2 лет** — устранение ретракции верхнего века и лагофтальма: золотой грузик в верхнее веко, кожно-хрящевой лоскут с ушной раковины, кантопексия, блефарорафия.

4.14 Гемифациальный спазм

Лечение первой линии — ботулинический токсин типа A с двух сторон, всего до 100 ЕД, лучше на ранних этапах.

Мишени

1. круговая мышца глаза;
2. щёчная мышца;
3. подкожная мышца шеи.

Улучшение у 76–100% в течение 7 дней, эффект **до 90 дней**, интервал **от 3 месяцев**.

Возврат спазма после васкулярной декомпрессии — ботулинический токсин, до 100 ЕД.

Нет показаний к операции, противопоказания, отказ или неэффективна ботулинотерапия — препараты

1. #карбамазепин 400–1200 мг в сутки;
2. #габапентин 600–1200 мг;
3. #клоназепам 0,5–4 мг, #диазепам и #лоразепам — в эквивалентных дозах;
4. #баклофен 15–80 мг;
5. #леветирацетам 500–1500 мг;
6. #зонисамид 150 мг 2 раза в сутки 6 недель.

Эффективность не доказана, частая седация и утомляемость.

Первичный спазм с нейроваскулярным конфликтом на МРТ — микроваскулярная декомпрессия корешка лицевого нерва; излечение **более 90%** за год.

При декомпрессии — интраоперационный мониторинг Lateral Spread Recording.

Операция не показана, противопоказана, отказ или неэффективны другие методы — радиохирургия лицевого нерва перед внутренним слуховым отверстием: 8 Гр однократно или 15 Гр за 5 фракций.

4.15 Лицевая миокимия

Первичная миокимия — покой, меньше кофеина, устранить провоцирующие факторы (курение, алкоголь); проходит за дни — недели. Вторичная — лечение причины.

Миокимия **более 3 месяцев** — сначала исключить другие причины, затем ботулинический токсин 5–20 ЕД в мышцу с гиперкинезом.

4.16 Невралгия языкоглоточного нерва

Три подхода, как при тригеминальной невралгии: консервативный, малоинвазивный, хирургический. Начинать с монотерапии, препараты добавлять поочерёдно.

#Карбамазепин — по правилам дозирования при тригеминальной невралгии, 100–2000 мг в сутки.

#Окскарбазепин — с 300 мг, постепенно до 1200 мг в сутки.

#Габапентин — по правилам при тригеминальной невралгии, 100–5000 мг в сутки.

Дополнительно — ботулинический токсин типа А по 1,25–5 ЕД внутрикожно в перикраниальные мышцы и мышцы шеи, всего 25–100 ЕД.

Импульсная радиочастотная абляция языкоглоточного нерва под КТ или УЗИ.

Блокада языкоглоточного нерва в проекции шиловидного отростка под КТ или УЗИ.

Фармакорезистентная первичная невралгия — микроваскулярная декомпрессия корешка в нейрохирургическом центре.

Декомпрессия невозможна или отказ — радиохирургия корешка (предпочтительно «Гамма-нож»).

Декомпрессия невозможна — частичная сенсорная ризотомия.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Реабилитация при нейропатии лицевого нерва

Медицинская реабилитация в остром и хроническом периоде: массаж лица, растяжение и расслабление, укрепление мышц лица и шеи, нервно-мышечное переобучение, биологическая обратная связь.

Тяжёлая нейропатия (V–VI степень): лечение положением (пластырь, кинезиотейп), массаж, пассивные упражнения. Лёгкая и умеренная (до IV степени): массаж, активные упражнения с дозированной симметричной нагрузкой. Пациенту объясняют: **избегать тепла, «грубого» массажа, электростимуляции, активной мимики** и упражнений с максимальной амплитудой.

Тяжёлая нейропатия — кинезиотейп на поражённую сторону: не дать мышцам перерастянуться, восстановить симметрию.

Тяжёлая нейропатия — пассивные упражнения; умеренная и лёгкая (IV степень и меньше) — активные с дозированным сокращением. **Активная ЛФК при тяжёлой нейропатии не рекомендуется**: здоровая сторона берёт гиперфункцию и смещает среднюю линию.

Комплекс упражнений для самостоятельного выполнения.

Биологическая обратная связь — зеркало (или миография).

Гипертонус здоровой стороны или риск его в остром периоде — упражнения на растяжение и расслабление мышц здоровой стороны.

Гипертонус и (или) синкинезии на поражённой стороне — растяжение и расслабление с двух сторон; синкинезии появляются **с 3-го месяца**.

Контроль домашней самореабилитации; обучение — на первичном приёме невролога.

Неосложнённый лагофтальм — днём пластырь или кинезиотейп на верхнее веко, подтягивание нижнего века при эктропионе; на ночь окклюзия глаза при несмыкании **более 4 мм**.

Неосложнённый лагофтальм — упражнения для баланса круговой мышцы глаза и леватора верхнего века.

Изолированное поражение краевой нижнечелюстной ветви — упражнения для мышцы, опускающей нижнюю губу, 2–3 раза в день перед зеркалом; при благоприятном прогнозе симметрия за 4–5 месяцев.

Дополнительно к стандартному лечению — иглорефлексотерапия, эффективнее в остром периоде.

Форсированные упражнения **не рекомендуются**: укорачивают мышечные волокна, повышают риск синкинезий.

Электростимуляция мышц **не рекомендуется**: по тем же причинам.

Гипербарическая оксигенация.

Лазерная физиотерапия (низко- и высокоинтенсивная) челюстно-лицевой области.

5.2 Диспансерное наблюдение

Сохраняются симптомы нейропатии лицевого нерва или гемифациального спазма — наблюдение невролога.

Сохраняется лицевая миокимия — наблюдение невролога.

5.3 Показания к госпитализации

Нейропатия лицевого нерва — экстренно

1. первые 72 часа — для внутривенного #метилпреднизолона в высокой дозе;
2. другие неврологические симптомы: слабость или онемение конечностей, головокружение, нарушение глотания;
3. ухудшение с нарушением сознания, лихорадкой, менингеальными симптомами;
4. декомпенсация давления или сахара, беременность.

Планово

1. операция.

Выписка

1. диагноз установлен;
2. состояние стабилизировано.

Тригеминальная невралгия — экстренно

1. впервые сильная боль в зоне глазничной ветви с вегетативными симптомами (отёк век, гиперемия склеры, потливость лба, изменение зрачка, слезотечение, ринорея или заложенность носа) — исключить патологию кавернозного синуса;
2. другие очаговые неврологические симптомы;
3. некупируемая боль.

Планово

1. малоинвазивные вмешательства и операции.

Выписка

1. диагноз установлен, боль уменьшилась, состояние стабильно.

Атипичная лицевая боль и автономные цефалгии — экстренно

1. нарушение сознания;
2. лихорадка и менингеальные симптомы;
3. нарастающая очаговая или общемозговая симптоматика;
4. некупируемая кластерная головная боль — для ингаляций кислорода.

Планово

1. нарастающая боль;
2. резистентная боль — ботулинотерапия или вмешательства (возможно в дневном стационаре).

Выписка

1. снижение интенсивности боли.

Тригеминальная нейропатическая боль: экстренно — подозрение на связь с Herpes zoster у пожилых, при иммунодефиците и онкологических заболеваниях; планово — вмешательства и операции.

1. **гемифациальный спазм** — планово — для операции
2. **лицевая миокимия** — амбулаторно
3. **другие черепные нервы** — экстренных показаний нет; планово — для вмешательств и операций

5.4 Исход

Полное восстановление — от **61%** при тотальной прозоплегии до **94%** при более лёгком парезе.

Осмотр не всегда отражает истинную тяжесть: при V–VI степени ЭНМГ обязательна; асимметрия М-ответа **более 90%** хотя бы по одной ветви — неблагоприятный прогноз. Гипертонус здоровой стороны — у 68,5% в первые 3 месяца, он ограничивает восстановление.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Краниальные мононейропатии у взрослых»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	895_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Союз реабилитологов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Ассоциация интервенционного лечения боли
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки реконструктивно-пластической операции при нейропатии лицевого нерва расходятся: в таблице 21 и разделе 2.5 — после 18 месяцев, в рекомендации раздела 3.2.1 — после 2 лет.
- Гемифациальный спазм в разделе 1.5 назван «первичный (симптоматический)», а в разделе 1.2 первичный спазм — от сдавления сосудом, симптоматический — вторичный.
- В разделе 2.3 рекомендация об анализах при гемифациальном спазме адресована «всем пациентам с НЛН»; в разделе 2.5.3 (другие черепные нервы) рекомендации о психиатре и нейрохирурге говорят о тригеминальной невралгии.
- У одной рекомендации о реиннервирующей операции (раздел 3.2.1) уровень убедительности указан как «СВ».
- Код G52.2 (поражения блуждающего нерва) есть в каталоге рубрикатора, но не в разделе 1.4 КР.